하루차림

암 치료 중 식사 이야기

가려 드시기 전에

치료가 시작되면 식탁에서 하나둘 빠지는 음식이 생깁니다. 대부분 걱정과 정성에서 나온 일이고, 치료를 마친 뒤에도 쉽게 풀리지 않습니다. 그런데 그렇게 줄어든 한 숟가락이 쌓이면 **치료를 견딜 힘도, 치료 뒤 회복할 힘도 함께 줄어듭니다.** 치료 중인 분과 치료를 마치신 분으로 나누어, 연구가 말하는 것과 아직 말하지 않는 것을 정리했습니다.

> 20년 넘게 암 환자를 치료해 온 방사선종양학과 전문의가 내용을 감수했습니다.

1 진료 시간에 다 듣기 어려웠던 이야기

2 주위에서 전해 들은 이야기

3 그 사이에 생기는 영양 부족

4 음식 하나하나를 살핀 자료

5 근거로 차리는 한 상

1 진료 시간에 다 듣기 어려웠던 이야기

얼마나 드시는지는, 진료실에서 잘 보이지 않습니다

진료 시간은 짧고, 그 시간에는 검사 결과와 치료 일정을 먼저 이야기하게 됩니다. "무엇을 피해야 하나요?"는 여쭤보셔도, "요즘 하루에 얼마나 드세요?"까지 오가기는 어렵습니다. 그런데 식사는 치료가 시작되기 전부터 이미 흔들리고 있는 경우가 많습니다.

51 %

이탈리아 22개 병원에서 처음 항암 진료를 받으러 온 환자 1,952명 가운데, 이미 영양 상태에 문제가 있거나 그 위험이 있던 분의 비율.[1]

64 %

같은 환자들 가운데 진료 전 6개월 동안 체중이 1~10 kg 줄어 있던 분. 치료를 시작하기도 전입니다.[1]

프랑스 전국 조사에서는 의사들이 환자의 식사량을 실제보다 많게 짐작했고, 나이 드신 환자에서 특히 그랬습니다.[2] 진료실에서는 잘 드시는 것처럼 보여도, 집 식탁은 다를 수 있다는 뜻입니다.

그래서 먼저 말씀드리고 싶은 세 가지

체중은 치료 경과의 일부입니다

6개월 안에 체중이 5 % 넘게 줄면(60 kg이면 3 kg) 담당 의료진께 알려야 할 신호입니다. 영양불량을 진단하는 국제 기준이 쓰는 문턱입니다.[3]

단백질은 오히려 더 필요합니다

치료 중에는 체중 1 kg당 하루 1~1.5 g을 권합니다. 60 kg이면 60~90 g입니다.[4]

따로 정해 받은 제한이 없다면, 가리기보다 드시는 것이 먼저입니다

담당 의료진이 정해 준 식사 제한(저요오드식, 수술 뒤 식사 단계 등)은 꼭 지키시고, 그 밖의 음식은 스스로 끊기 전에 한 번 더 확인해 주세요.

치료를 마치신 뒤에는

진료 간격이 벌어지면, 식사를 여쭤볼 기회도 줄어듭니다

치료가 끝나면 진료는 몇 달에 한 번이 됩니다. 국내 유방암·부인암 생존자 186명 가운데 진단 2~5년째 분의 43 %가 식사 문제를 겪었고, 약 90 %가 피해야 할 음식과 재발에 관한 식사 상담을 원했습니다.[20] 같은 시기에 부인암 생존자의 34.5 %는 체중이 줄었고, 유방암 생존자의 27.1 %는 늘었습니다. 회복기의 체중은 어느 쪽으로든 움직입니다.

그래서 치료를 마친 뒤에도 체중을 재 주세요. 의도하지 않게 줄거나 크게 늘면 다음 진료 때 알려 주세요.

2 주위에서 전해 들은 이야기

걱정에서 나온 말이, 식탁을 좁힙니다

먼저 치료받은 친척, 같은 병실 환자분, 인터넷 카페에서 전해 들은 이야기는 대개 정성에서 나옵니다. 다만 그 말들이 하나둘 겹치면, 드실 수 있는 음식이 생각보다 빠르게 줄어듭니다.

78.2%

국내 온라인 암 환우 모임 응답자 221명 가운데 보완·대체요법을 써 본 분. 그중 주치의와 상의한 분은 30.6 %였습니다. [5]

32.5%

미국 SNS에서 많이 공유된 암 치료 글 200건 가운데 잘못된 정보가 담긴 글. 해로울 수 있는 글이 반응을 더 많이 받았습니다. [6]

86%

홍콩의 암 환자 245명 가운데 음식을 가리는 분. 많이 가릴수록 단백질·아연·철을 적게 드셨습니다. [7]

그 가운데 자주 듣는 이야기 다섯 가지를 원문으로 확인했습니다.

"암 환자는 고기를 끊어야 한대요."

고기·유제품을 통째로 끊을 근거는 없습니다.

진단 뒤 식사를 다룬 전향 연구 29편을 모은 분석은 어떤 식품군도 없앨 필요는 없다고 결론지었습니다. 줄이실 것은 햄·소시지 같은 가공육이고, 단백질은 오히려 넉넉히 드셔야 합니다. [8,4]

"유방암이면 두부·된장·두유를 끊어야 한대요."

끊지 않으셔도 됩니다.

유방암 환자 9,514명 연구에서 콩 이소플라본을 하루 10 mg 이상 드신 분들의 재발이 25 % 낮았습니다. 농축 보충제는 따로 봅니다. [9]

"항암 중에는 생과일·생채소를 먹으면 안 된대요."

잘 씻어 드시면 됩니다. 새싹채소만은 익혀 드세요.

가려 먹는 식단이 감염을 줄인다는 근거는 6편·1,114명 분석에서 확인되지 않았습니다. 담당 의료진이 따로 정해 준 기준이 있으면 그것을 먼저 따르세요. [10]

"설탕이 암을 키우니 단 것은 다 끊어야 한대요."

끊는다고 암이 굶는다는 연구는 없습니다. 다만 단 음료는 줄이세요.

설탕을 끊은 환자의 결과를 본 시험은 찾지 못했습니다. 한편 3기 대장암 1,011명 관찰에서 가당 음료를 하루 2잔 넘게 마신 분은 재발·사망 위험이 높았습니다(1.67배). 밥과 과일까지 끊을 일은 아닙니다. [11]

"굶으면 암도 굶는대요."

혼자 시작하는 단식은 권하지 않습니다.

프랑스 생존자 2,741명 가운데 6.0 %가 단식을 해 보았고, 예후가 좋아질 거라는 믿음과 관련이 있었습니다. 의료진에게 영양 정보를 받은 분은 단식을 덜 했습니다. 단식은 지금 의료진이 관리하는 시험 안에서 연구되는 단계이고, 그 시험도 마른 분과 당뇨가 있는 분은 받지 않았습니다. [12,13]

치료를 마치신 뒤에는

치료를 마친 뒤에 오히려 더 가리게 됩니다

호주에서 근치 치료를 마친 생존자 520명 가운데 55 %가 진단 뒤 식사를 바꾸었습니다. 붉은 고기를 줄이거나 끊은 분이 25 %, 유제품을 일부러 피한 분이 7 %였고, 61 %가 영양제를 드셨습니다. 그런데 채소 권장량을 채운 분은 20 %뿐이었습니다. [21]

국내 건강검진 코호트에서도 암 생존자 5,269명은 같은 나이·성별의 건강한 분들보다 고기·가금류에서 얻는 열량의 비중이 낮았습니다. [22] 위 다섯 번째 이야기의 단식·감량 식이 숫자도 치료를 마친 생존자에게서 나온 것입니다. [12]

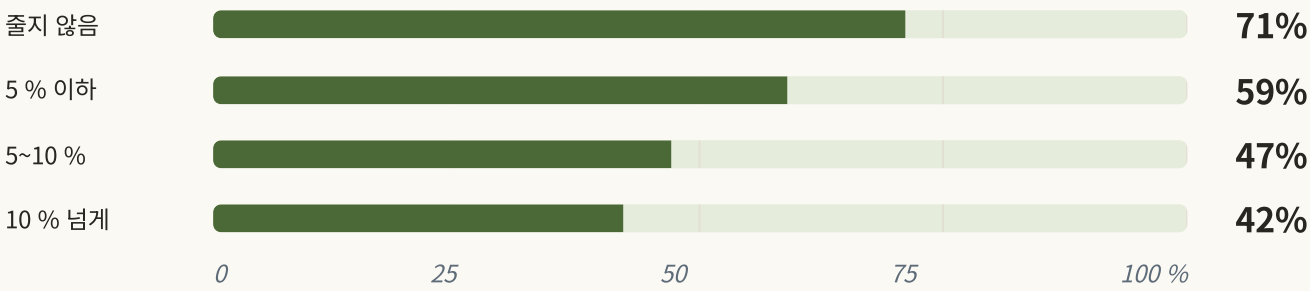
3 그 사이에 생기는 영양 부족

체중이 줄면, 치료를 견디기가 어려워집니다

꼭 필요한 제한 하나도 식탁 전체를 줄입니다. 서울대병원에서 갑상선암 환자 92명이 방사성 요오드 치료를 앞두고 저요오드식을 하는 동안, 하루 열량이 평소보다 **446 kcal** 적었습니다.[14] 꼭 필요해서 하는 제한도 이렇습니다. 그래서 제한은 필요한 만큼, 필요한 기간만 하는 것이 좋습니다.

방사선치료 전 체중이 줄어든 정도와 5년 생존율

두경부암으로 방사선치료를 받은 1,340명, 네덜란드[15]



나이·병기 같은 다른 요인을 맞춘 뒤에도, 치료 전 10 % 넘게 줄었던 분의 사망 위험은 1.7배였습니다. 치료 중에 체중이 크게 준 경우도 결과가 나빴습니다.

부작용은 늘고, 받은 치료는 줄었습니다

위장관암으로 항암치료를 받은 1,555명에서, 체중이 줄어 있던 분은 손발 피부 반응과 입안 염증이 더 잦고 심했습니다. 치료는 평균 한 달(18 %) 덜 받으셨습니다. 연구진은 결과가 나빴던 까닭을 약이 덜 들어서가 아니라, 치료를 덜 받고 부작용이 많았던 데서 찾았습니다.[16]

많이 줄고 마를수록, 생존 기간이 짧았습니다

캐나다·유럽 8,160명에서 체중 감소와 마른 정도를 함께 본 등급에 따라 생존 기간 중앙값이 20.9개월부터 4.3개월까지 벌어졌습니다.[17]

근육은 체중계에 바로 드러나지 않습니다

38편·7,843명을 모은 분석에서 CT로 잰 근육량이 적은 분은 사망 위험이 1.44배였습니다.[18] 단백질을 챙기는 이유입니다.

치료를 마치신 뒤에는

치료가 끝난 뒤의 체중도 같은 이야기를 합니다

- **위암 수술 뒤** — 국내 2,063명에서 수술 뒤 저체중(BMI 18.5 미만)이면 사망 위험이 1.74배, BMI가 4.5 넘게 빠지면 1.79배였습니다.[23] 수술과 항암을 마치고 1년 넘게 지낸 958명에서는 첫 1년 동안 근육이 덜 빠진 분의 5년 생존율이 75.7 %, 많이 빠진 분은 66.2 %였습니다.[24]
- **식도암 수술 뒤** — 재발 없이 1년을 넘긴 205명 가운데 그 1년 동안 체중이 10 % 넘게 줄었던 분의 5년 무병생존율은 48 %, 그렇지 않은 분은 66 %였습니다.[25]
- **유방암 진단 뒤** — 12,915명을 모은 분석에서 10 % 넘게 줄었던 분의 사망 위험이 미국 1.41배, 상하이 3.25배였습니다. 다만 일부러 뺀 것인지는 가리지 못했습니다.[26]

반대쪽도 있습니다. 회복기에는 빠지는 것만큼 느는 것도 봐야 합니다.

빠지기 쉬운 분 — 위·식도 수술 뒤, 두경부 방사선치료 뒤

줄지 않게 지키는 것이 먼저입니다. 드실 수 있는 것을 자주, 단백질을 챙겨서 드세요.

늘기 쉬운 분 — 유방암 치료 뒤 등

유방암 12편·23,832명 분석에서 10 % 넘게 늘면 사망 위험이 1.23배였습니다.[27] 이때도 굶기가 아니라 식사의 질과 운동입니다. 과체중 유방암 생존자 시험에서 식사만으로 뺀 분은 근육(제지방)도 0.82 kg 함께 줄었고, 운동만 한 분은 근육이 줄지 않았습니다.[29]

117편·209,597명을 모은 분석에서 진단 뒤 질 좋은 식사를 한 분의 사망 위험은 0.79배, 서구식 식사는 1.51배였습니다.[28] 무엇을 끊느냐보다 무엇으로 채우느냐가 남습니다.

연구가 아직 말하지 않는 것

- 위 연구는 모두 **관찰 연구**입니다. 체중이 줄어서 결과가 나빴는지, 병이 깊어서 체중이 줄었는지를 완전히 가를 수는 없습니다.
- 영양 상담과 보충은 식사량·체중·삶의 질을 지키는 데 도움이 되었습니다. 그러나 13개 시험·1,414명을 모은 분석에서 **생존을 늘렸다는 결과는 나오지 않았습니다**(사망 위험 1.06배, 차이 없음).[19]
- 치료를 마친 유방암 환자 3,088명에게 채소·과일·섬유를 크게 늘리고 지방을 줄인 식단을 권한 무작위 시험에서도, 7년여 동안 **재발과 사망은 줄지 않았습니다**.[30] 특정 식단 하나로 예후를 바꿀 수 있다는 근거는 아직 없습니다.
- 그래서 하루차림은 "잘 드시면 오래 사신다"고 말하지 않습니다. 치료를 끝까지 받으시고, 마친 뒤에는 일상으로 돌아오실 수 있도록 몸을 지키는 일로 봅니다.

4 음식 하나하나를 살핀 자료

같은 음식도, 누가 드시느냐에 따라 답이 다릅니다

'좋은 음식·나쁜 음식' 목록은 편하지만, 한 가지 답으로는 모든 분께 맞출 수 없습니다. 그래서 음식마다 성분을 따로 쌓고, 암 종류·치료 시기·증상·드시는 약에 따라 판단을 나누었습니다. 치료 시기는 방사선치료 중·항암치료 중·호중구가 낮은 시기·수술 뒤 회복기·치료를 마친 뒤로 나눕니다.

광어(회)	호중구가 낮은 시기	피하세요	치료를 마친 뒤	권함
새우젓	위암	피하세요	유방암	주의
청국장	와파린 복용 중	주의	복용약 없음	권함

291,378
음식·식품
기본 음식 18,298 + 시판 가공식품 273,080. 영양성분은 국가표준식품성분표와 제품 표시값

50,524
건강기능식품
국내 45,618 + 수입 4,906. 원료마다 암 종류·복용약에 따라 따로 판단

4,695
의약품 이름
영양제로 착각하기 쉬운 의약품은 판정하지 않고 "의약품입니다"라고 알려 드림

158
판단 규칙
음식 130 + 약물–음식 상호작용 28. 규칙마다 근거 등급

172
참고 문헌
요약이 아니라 원문을 받아 앱 문장과 한 줄씩 대조

177,971
알레르기 원재료
알레르기 19종을 원재료 표시와 대조

영양 목표는 2025 한국인 영양소 섭취기준과 유럽임상영양대사학회(ESPEN) 암 영양 지침을 따릅니다. 판단의 근거가 된 문헌은 앱 안에서 항목마다 열어 보실 수 있습니다.

5 근거로 차리는 한 상

빼는 목록이 아니라, 채우는 상차림

하루차림은 무엇을 피할지만 알려 드리지 않습니다. 체중과 치료 시기에 맞춰 하루 목표를 정하고, 밥을 먼저 앉힌 뒤 반찬과 국을 더해 한국식 한 상을 차립니다. 앞에서 본 근거가 화면에서는 이렇게 쓰입니다.

체중에 맞춘 하루 목표

키·체중·치료 시기로 하루 열량과 단백질 목표를 셈합니다. 단백질은 체중 1 kg당 1~1.5 g을 기준으로 잡습니다.[4]

체중이 줄면, 먼저 채웁니다

6개월 안에 5 % 넘게 줄면 알려 드립니다. 입안이 헐거나 설사·메스꺼움 때문에 '피하세요'로 두었던 음식 일부는 '주의'로 낮춥니다. 지금은 드실 수 있는 것을 드셔서 열량과 단백질을 채우는 것이 먼저이기 때문입니다.[3,4]

치료를 마치신 뒤에는 유지 수준으로

치료가 끝나고 체중이 지켜지면 열량 목표를 유지 수준으로 잡고, 체중이 다시 줄기 시작하면 원래 목표로 되돌립니다. 위를 수술하신 분께는 비타민 B12·철·칼슘을, 대장암을 회복하신 분께는 식이섬유를, 유방암 치료를 마치신 분께는 체중이 늘지 않게 지키기를 따로 안내합니다.

모자란 날을 짚어 드립니다

하루치 평균만 보지 않고, 일주일 가운데 며칠이나 열량·단백질이 모자랐는지 함께 보여 드립니다.

왜 권하는지까지

반찬마다 근거 등급(A·B·C·G)과 출처가 붙습니다. 근거가 없는 것은 "아직 모릅니다"라고 적습니다.



일주일 기록에서 모자란 것을 짚어 드립니다(예시 화면)



반찬마다 왜 권하는지와 근거 등급이 붙습니다(예시 화면)

오늘 한 상부터 차려 보세요

암 종류·치료 시기·드시는 약을 넣으면 하루 세 끼 한식 상차림을 추천합니다. 치료를 대신하지 않으며, 모든 안내는 "담당 의료진과 상의하세요"로 끝납니다. 기록은 기기 안에 저장됩니다.

하루차림은 의료기기가 아니며 진단·치료를 목적으로 하지 않습니다. 이 페이지는 일반 정보이며, 개인의 치료와 식사는 담당 의료진과 정하십시오. 만 14세 이상 이용할 수 있습니다.

근거 목록

논문 수치는 모두 PubMed 초록 원문과 대조했습니다(2026년 11월 9일). 앱 숫자는 같은 날 앱 자료에서 셈한 값입니다.

1. Muscaritoli M, et al. Prevalence of malnutrition in patients at first medical oncology visit: the PreMiO study. Oncotarget. 2017;8:79884-96. PMID 29108370. doi:10.18632/oncotarget.20168
2. Lacau St Guily J, et al. NutriCancer: malnutrition in elderly patients with cancer. J Geriatr Oncol. 2018;9:74-80. PMID 28888553. doi:10.1016/j.jgo.2017.08.003
3. Cederholm T, et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2019;10:207-17. PMID 30920778. doi:10.1002/jcsm.12383
4. Muscaritoli M, et al. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in cancer. Clin Nutr. 2021;40:2898-913. PMID 33946039. doi:10.1016/j.clnu.2021.02.005
5. Kim JS, et al. Complementary and alternative medicine among patients with cancer in Korea (KCSG PC21-20). Cancer Res Treat. 2023;55:442-51. PMID 36596728. doi:10.4143/crt.2022.1483
6. Johnson SB, et al. Cancer misinformation and harmful information on Facebook and other social media. J Natl Cancer Inst. 2022;114:1036-9. PMID 34291289. doi:10.1093/jnci/djab141
7. Yung TKC, et al. Protein food avoidance behaviour among cancer patients. Asia Pac J Clin Nutr. 2022;31:191-200. PMID 35766554. doi:10.6133/apjcn.202206_31(2).0004
8. Rinninella E, et al. The facts about food after cancer diagnosis: a systematic review of prospective cohort studies. Nutrients. 2020;12:2345. PMID 32764484. doi:10.3390/nu12082345
9. Nechuta SJ, et al. Soy food intake after diagnosis of breast cancer and survival. Am J Clin Nutr. 2012;96:123-32. PMID 22648714. doi:10.3945/ajcn.112.035972
10. Ma Y, et al. Neutropenic diet cannot reduce the risk of infection and mortality in oncology patients with neutropenia. Front Oncol. 2022;12:836371. PMID 35356218. doi:10.3389/fonc.2022.836371
11. Fuchs MA, et al. Sugar-sweetened beverage intake and cancer recurrence and survival in CALGB 89803. PLoS One. 2014;9:e99816. PMID 24937507. doi:10.1371/journal.pone.0099816
12. Fassier P, et al. Fasting and weight-loss restrictive diet practices among 2,700 cancer survivors (NutriNet-Santé). Int J Cancer. 2018;143:2687-97. PMID 29971783. doi:10.1002/ijc.31646
13. de Groot S, et al. Fasting mimicking diet as an adjunct to neoadjuvant chemotherapy for breast cancer (DIRECT). Nat Commun. 2020;11:3083. PMID 32576828. doi:10.1038/s41467-020-16138-3
14. Ju DL, et al. Dietary evaluation of a low-iodine diet in Korean thyroid cancer patients. Nutr Res Pract. 2016;10:167-74. PMID 27087900. doi:10.4162/nrp.2016.10.2.167
15. Langius JAE, et al. Critical weight loss is a major prognostic indicator for disease-specific survival in head and neck cancer receiving radiotherapy. Br J Cancer. 2013;109:1093-9. PMID 23928661. doi:10.1038/bjc.2013.458
16. Andreyev HJ, et al. Why do patients with weight loss have a worse outcome when undergoing chemotherapy for gastrointestinal malignancies? Eur J Cancer. 1998;34:503-9. PMID 9713300. doi:10.1016/s0959-8049(97)10090-9
17. Martin L, et al. Diagnostic criteria for the classification of cancer-associated weight loss. J Clin Oncol. 2015;33:90-9. PMID 25422490. doi:10.1200/JCO.2014.56.1894
18. Shachar SS, et al. Prognostic value of sarcopenia in adults with solid tumours: a meta-analysis. Eur J Cancer. 2016;57:58-67. PMID 26882087. doi:10.1016/j.ejca.2015.12.030
19. Baldwin C, et al. Oral nutritional interventions in malnourished patients with cancer: a systematic review and meta-analysis. J Natl Cancer Inst. 2012;104:371-85. PMID 22345712. doi:10.1093/jnci/djr556
20. Lee SY, et al. Nutritional care needs of breast and gynecologic cancer survivors in Korea. PLoS One. 2016;11:e0163281. PMID 27695041. doi:10.1371/journal.pone.0163281
21. Tan SY, et al. Dietary changes and supplement use among cancer survivors after curative treatment. Support Care Cancer. 2021;29:6979-87. PMID 34031752. doi:10.1007/s00520-021-06276-9
22. Hoang T, et al. Food intake behavior in cancer survivors in comparison with healthy general population (Health Examinees cohort). J Cancer Prev. 2019;24:208-16. PMID 31950020. doi:10.15430/JCP.2019.24.4.208
23. Park YS, et al. Prognostic roles of perioperative body mass index and weight loss in the long-term survival of gastric cancer patients. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2018;27:955-62. PMID 29784729. doi:10.1158/1055-9965.EPI-18-0122
24. Kim KW, et al. Preoperative nutritional risk index and postoperative one-year skeletal muscle loss can predict the prognosis of gastric adenocarcinoma. BMC Cancer. 2021;21:157. PMID 33579228. doi:10.1186/s12885-021-07885-7
25. D'Journo XB, et al. Prognostic impact of weight loss in 1-year survivors after transthoracic esophagectomy for cancer. Dis Esophagus. 2012;25:527-34. PMID 22121887. doi:10.1111/j.1442-2050.2011.01282.x
26. Caan BJ, et al. Weight change and survival after breast cancer in the After Breast Cancer Pooling Project. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2012;21:1260-71. PMID 22695738. doi:10.1158/1055-9965.EPI-12-0306
27. Playdon MC, et al. Weight gain after breast cancer diagnosis and all-cause mortality: systematic review and meta-analysis. J Natl Cancer Inst. 2015;107:djv275. PMID 26424778. doi:10.1093/jnci/djv275
28. Schwedhelm C, et al. Effect of diet on mortality and cancer recurrence among cancer survivors: a meta-analysis of cohort studies. Nutr Rev. 2016;74:737-48. PMID 27864535. doi:10.1093/nutrit/nuw045
29. Brown JC, et al. A randomized trial of exercise and diet on body composition in survivors of breast cancer with overweight or obesity. Breast Cancer Res Treat. 2021;189:145-54. PMID 34089422. doi:10.1007/s10549-021-06284-7
30. Pierce JP, et al. Influence of a diet very high in vegetables, fruit, and fiber and low in fat on prognosis following treatment for breast cancer (WHEL). JAMA. 2007;298:289-98. PMID 17635889. doi:10.1001/jama.298.3.289